

喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用

薛 珊

(江苏省阜宁县夕阳红药店,江苏 阜宁 224400)

摘要 了解喹诺酮类药物的不良反应及药物间的相互作用。

关键词 喹诺酮;不良反应;相互作用

[中图分类号] R978.1

[文献标识码] B

学科分类代码: 350.35

文章编码: 1001-8131(2008)03-0035-01

1 不良反应

1.1 变态反应及光毒性:使用喹诺酮类药物后,发生在个别特殊体质者。主要表现为皮疹、荨麻疹、皮炎和剥脱性皮炎等。以环丙沙星和诺氟沙星为多。此类反应大都较重,一般发生在服药后几天至数周后,可见哮喘、呼吸困难、喉头水肿、血管性水肿、过敏性脉管炎和过敏性休克等严重过敏反应。此类药物引起的光毒性与药物结构、阳光照射、自身的敏感性有密切关系。喹诺酮药吸收后,使紫外线能量大部分在皮肤中释放,由光激发而致皮肤细胞的损伤,表现为红斑、水肿、疼痛、脱屑、褪皮、皮疹、水泡和色素沉着,严重者可能被灼伤。

1.2 软骨毒性:主要影响新生或幼小动物的骺增长板。虽在人类中尚未发现。但少数病例出现严重关节疼痛和炎症。因此喹诺酮类药物不宜用于骨骼系统尚未发育完全的 16 周岁以下的人群,孕妇和哺乳期禁用。

1.3 胃肠道的作用:一般表现为恶心、呕吐、食欲不振,腹痛、腹胀,长期使用可致细菌性腹泻。

1.4 对心脏的毒性作用:大多表现为胸闷、头晕、心慌、气短、呼吸困难等症状,停药后可自行恢复。

1.5 对肝脏的毒性作用:大量或长期应用该类物易致肝损害,表现为药物性黄疸、巩膜、皮肤和黏膜黄染。

1.6 对中枢神经系统的作用:中枢神经系统毒性反应包括头痛、眩晕、疲倦、失眠、视觉异常和噩梦,严重神经毒性作用很少。

1.7 对肾脏的毒性:大多以原形从尿中排泄,主要有血尿、结晶尿,有的患者还可出现高尿酸血症,过敏性间质性肾炎或少尿性肾衰。

1.8 血液系统反应:急性粒细胞减少,表现为全身乏力、发热。

2 药物相互作用

2.1 与其它抗生素的相互作用

2.1.1 协同作用:磺胺类药物可明显增加环丙沙星抗绿脓杆菌和金葡萄菌的作用。与 β -内酰胺类和氨基糖甙类抗生素合用有协同作用,对革兰阳性菌及部分绿脓杆菌和金葡萄菌作用增强;与亚胺培南或阿米卡星合用,体外证实对这两种抗生素耐药的作用增强;与阿洛西林合用,对绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和不动杆菌菌属细菌有协同作用;与克林霉素合用,对链球菌、葡萄球菌有协同作用,对革兰氏阳性菌作用增

强;低浓度时与咪康唑、酮康唑和依他康唑有协同作用;体外显示,阿齐赛素与氟喹诺酮类药物有协同抗菌作用;喹诺酮类药物与抗结核药物联用对非典型分支杆菌有协同作用。

2.1.2 拮抗作用:喹诺酮类与利福平、绿霉素等合用可产生拮抗作用,使其抗菌作用下降或抵消;还可拮抗两性霉素 B 和美帕曲星的作用;部分拮抗 5-氟尿嘧啶作用。

2.1.3 合用使毒副作用增加:(1)喹诺酮类与万古霉素合用可致毒性增加,出现肾小管上皮损害,蛋白尿等中毒症状。(2)喹诺酮类与绿霉素、红霉素合用可致效用降低。同时,对肝、肾功能及神经系统的不良反应进一步加重。(3)环丙沙星与阿霉素、呋喃妥因合用,增加了毒性,并且对肾功能不全者损害更大。

2.2 与其它类药物的相互作用:喹诺酮类药物抑制茶碱类药物的代谢,使茶碱血浓度升高,导致茶碱中毒,老人尤易发生,因此不宜与茶碱类合用;碱性药物、抗胆碱药、H²受体阻滞剂(西米替丁、雷尼替丁、奥美拉唑等)均可降低胃液酸度,从而减少本类药物的吸收,故应避免同服;不宜与碱化剂同时服用;含钙、镁、铝的抗酸剂由于阳离子与喹诺酮类药物发生络合反应,可降低本类药的吸收作用,故应避免合用;本类药不宜与抗惊厥药合用,与 GABA 合用时相互作用,产生多种精神症状,易诱发癫痫。与非甾体抗炎药(布洛芬、芬布芬等)合用,可引起中枢性痉挛发作;与口服抗凝血药物如华法令同时使用有增加出血的危险。

3 结语

药物不良反应对人体所造成的损害,既可能是短暂的逆性的功能损害,也可能为长期的不可逆性的器质性病变。因此,临床医师必须根据患者的病情合理用药,一旦发生不良反应立即停药,妥善处理,避免不良后果的发生。而药师则要充分做好 ADR 的同时,加大药品知识的宣传力度,协助临床医师保证患者的用药安全。

参考文献

[1] 连需强,张立衡,吴照刚.喹诺酮类药物不良反应及相互作用.中国医院药学杂志,2002,22.
[2] 陈新谦,金有豫.新编药理学.14版.北京人民卫生出版社,1998:91.
[3] 崔家刚.江西医药,2007,42(3).

收稿日期:2008-02-22